

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

MODULO DI AUDIT RISCHIO CLINICO

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD009_00	00	12/04/2026	6
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
DS / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: TD-SGI-PRO015 Sez. 8.2 (Audit clinico) · TD-SGI-PLN005 Ambito G (Programma audit clinici G1-G5)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

SEZIONE A – DATI GENERALI DELL'AUDIT	
Data dell'audit	
Sede / Struttura auditata	
Auditor principale (nome e qualifica)	
Componenti del team di audit	
Personale intervistato / presente	

Tipologia di audit (barrare):

☐ G1 – Qualità analitica	☐ G2 – TAT e valori critici	☐ G3 – Consenso informato e questionario RM
☐ G4 – Protocolli radiologici (dose)	☐ G5 – Sicurezza RM	☐ Altro: _____

Rif. programma audit (PLN005 cod. obiettivo)	
Periodo di riferimento dei dati	

SEZIONE B – Checklist G1: Qualità analitica (rif. PRO015 Sez. 5.1)

C = Conforme | NC = Non Conforme | N/A = Non Applicabile

N.	Elemento verificato	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	Il tasso di emolisi dei campioni è monitorato mensilmente per sede				
2	Il tasso di emolisi è ≤ 2% (target PLN005 B1)				
3	Il tasso di campioni inadeguati è monitorato e ≤ 1% (target PLN005 B2)				
4	Le cause di inadeguatezza sono analizzate per tipologia (emolisi, volume, contenitore errato)				
5	Il CQI è eseguito giornalmente su tutti gli analiti e i risultati sono documentati				
6	Le regole di Westgard sono applicate e le azioni correttive per CQI fuori controllo sono registrate				
7	La VEQ è attiva per tutti i programmi disponibili e la performance è ≥ 95%				
8	Le NC da VEQ sono analizzate con azioni correttive documentate				
9	La calibrazione delle catene analitiche è eseguita secondo le specifiche del costruttore				
10	La validazione tecnica automatica (regole di plausibilità) è attiva e aggiornata				
11	La validazione clinica da parte del biologo/patologo è effettuata su tutti i referti				

SEZIONE C – Checklist G2: TAT e valori critici (rif. PRO015 Sez. 5.1)

C = Conforme | NC = Non Conforme | N/A = Non Applicabile

N.	Elemento verificato	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	Il TAT per gli esami urgenti è monitorato e $\geq 95\%$ entro 60 minuti (target PLN005 B4)				
2	Il TAT per gli esami routinari è monitorato e rispetta i tempi dichiarati nella Carta dei Servizi				
3	L'elenco dei valori critici (panic values) è definito, aggiornato e accessibile al personale				
4	La comunicazione dei valori critici avviene entro 30 minuti dalla validazione (target PLN005 B3)				
5	La comunicazione è effettuata telefonicamente al medico richiedente o al paziente				
6	La comunicazione è registrata (nome comunicante, destinatario, ora, valore, conferma ricezione)				
7	I valori critici non comunicati per irreperibilità del destinatario sono gestiti con procedura di escalation				
8	Il sistema LIS genera un alert automatico per i valori critici				

SEZIONE D – Checklist G3: Consenso informato e questionario RM (rif. PRO015 Sez. 5.2, 5.5)

C = Conforme | NC = Non Conforme | N/A = Non Applicabile

N.	Elemento verificato	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	Il consenso informato per la somministrazione di mdc (iodato e gadolinio) è acquisito e firmato prima della procedura				
2	Il modulo di consenso contiene informazioni chiare sui rischi, le alternative e la possibilità di rifiuto				
3	La verifica della creatinina/eGFR è documentata prima di ogni TC con mdc iodato (target PLN005 C2)				
4	Il questionario pre-RM è compilato integralmente e firmato dal paziente per ogni esame RM (target PLN005 C1)				
5	Il questionario include le domande su: pacemaker, impianti metallici, neurostimolatori, pompe insuliniche, clip vascolari, protesi, gravidanza, claustrofobia				
6	Il TSRM verifica il questionario e controfirma prima dell'accesso alla sala magnete				
7	In caso di dubbio sulle controindicazioni, il medico radiologo è consultato prima di procedere				
8	Il consenso informato per procedure invasive (biopsie eco-guidate) è acquisito e archiviato				
9	I moduli di consenso sono conservati nella documentazione clinica del paziente				

SEZIONE E – Checklist G4: Protocolli radiologici e dose (rif. PRO015 Sez. 5.2, PRO011)

C = Conforme | NC = Non Conforme | N/A = Non Applicabile

N.	Elemento verificato	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	I protocolli TC sono ottimizzati secondo le indicazioni del costruttore e del medico radiologo				
2	Il DLP (Dose Length Product) medio per TC encefalo è entro i DRL nazionali (Rapporti ISTISAN)				
3	Il DAP (Dose Area Product) medio per RX torace è entro i DRL nazionali				
4	La dose ghiandolare media per mammografia è monitorata e entro i DRL				
5	Il principio ALARA è documentato e applicato (giustificazione, ottimizzazione)				
6	La giustificazione dell'esame radiologico è documentata nella richiesta del medico prescrivente				
7	Lo stato di gravidanza è verificato prima di esami con radiazioni ionizzanti per donne in età fertile				
8	I controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche sono effettuati secondo il programma dell'EdR				
9	I risultati dei controlli di qualità sono documentati e le NC sono gestite con azioni correttive				

SEZIONE F – Checklist G5: Sicurezza RM (rif. PRO015 Sez. 5.2)

C = Conforme | NC = Non Conforme | N/A = Non Applicabile

N.	Elemento verificato	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	Le zone di accesso alla RM sono classificate (Zona I-IV) e segnalate con cartellonistica conforme				
2	Il metal detector è posizionato all'ingresso della zona controllata ed è funzionante				
3	L'accesso alla sala magnete è controllato e limitato al personale autorizzato				
4	Il personale che accede alla sala magnete ha superato la formazione sulla sicurezza RM				
5	I materiali e le attrezzature presenti nella sala magnete sono certificati RM-compatibili				
6	Il kit di emergenza per quench è disponibile e il personale conosce la procedura				
7	La procedura di emergenza medica nella sala magnete è definita e il personale è addestrato				
8	Le bobine e i cavi sono posizionati correttamente per prevenire ustioni da radiofrequenza				
9	Il protocollo per pazienti claustrofobici è definito e applicato				
10	L'ultimo test di sicurezza RM (simulazione emergenza sala magnete) è documentato				

SEZIONE G – Sintesi, non conformità e azioni correttive

RIEPILOGO ESITO AUDIT	
Totale elementi verificati	
Conformi (C)	
Non Conformi (NC)	
Non Applicabili (N/A)	
Percentuale di conformità (%)	

Dettaglio delle Non Conformità rilevate e azioni correttive:

NC N.	Descrizione della NC	Azione correttiva proposta	Responsabile	Scadenza	Verifica efficacia
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Osservazioni e raccomandazioni dell'auditor	
Punti di forza rilevati	
Opportunità di miglioramento	

Auditor principale – Firma e data	Responsabile area auditata – Firma e data
Direttore Sanitario – Firma e data	RSGI – Firma e data

Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani